

d 開胸, 手術

開胸の適応は制御困難な出血増加や呼吸状態の悪化, 開放創となった場合, 重要臓器の損傷が疑われた場合である。

血胸での開胸止血に踏み切る目安は, 胸腔ドレーン挿入時に 1,000~1,500 mL の出血量を観察した場合や, 数時間にわたり 200 mL/hr 以上出血が持続し減少がみられない場合に考慮する^{6, 7)}。肺門部損傷や血管損傷では, 肺葉切除や肺全摘術が実施されることもあるが, 全摘の死亡率は高いので, なるべく回避すべきである。

1/3 周を超える気管・気管支壁損傷や大きな組織欠損, 持続する気漏, 他の受傷臓器修復のための気道確保が必要な場合には気管支壁の直接縫合閉鎖や気管支形成術を行う (図 2c)。

心・大血管損傷は, 開胸蘇生術や, 病態により心臓血管外科医による人工心肺補助での修復が行われる。最近では血管内治療が考慮されることもある。

解剖学的に生命維持に重要な臓器が集まる胸部外傷

では, 重篤な病態に陥っていることがある。これらをよく理解し迅速かつ的確な診断と処置や治療により, 救命率の向上が期待できる。

文 献

- 1) 日本外傷データバンク報告 2023 年 (<http://www.jtcr-jatec.org/traumabank/dataroom/data/JTDB2023>.)
- 2) Besson A, et al : A colour atlas of Chest Trauma and associated injuries vol 2, Mosby, 1983
- 3) ワシントン外科マニュアル 外傷外科, メディカルサイエンスインターナショナル, p497-544, 2009
- 4) Karmy-Jones R, et al : Management of blunt chest and diaphragmatic injuries. Peason's Thoracic & Esophageal Surgery, 3rd Ed, Churchill livingstone Elsevier, p1768-1776, 2008
- 5) 日本救急医学会 (監修): 外傷初期診療ガイドライン, へるす出版, 2013
- 6) Burack JH : Pathophysiology and initial management of thoracic trauma. Peason's Thoracic & Esophageal Surgery, 3rd Ed, Churchill livingstone Elsevier, p1723-1737, 2008
- 7) 吉田康浩ほか: 呼吸 33 : 404, 2014